

אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיגור

בטיפול באנשים עם מוגבלות קוגניטיבית חשוב לדבר גם עם ההורה או המטפל העיקרי. יש לזכור כי גם המטופלים עצמם יתקשו לפעמים להסביר לצוות הרפואי מה הבעיה.

הדברים שמקשים על לקיחת אנמנזה ואבחון הם: קשיי תקשורת עם המטופל, המטופל עצמו לא תמיד מודע לבעיה שממנה הוא סובל. יש מטופלים שנמצאים בהשפעת תרופות, והמוגבלות שלהם מתבטאת בתגובה דלה לגירויי הסביבה.

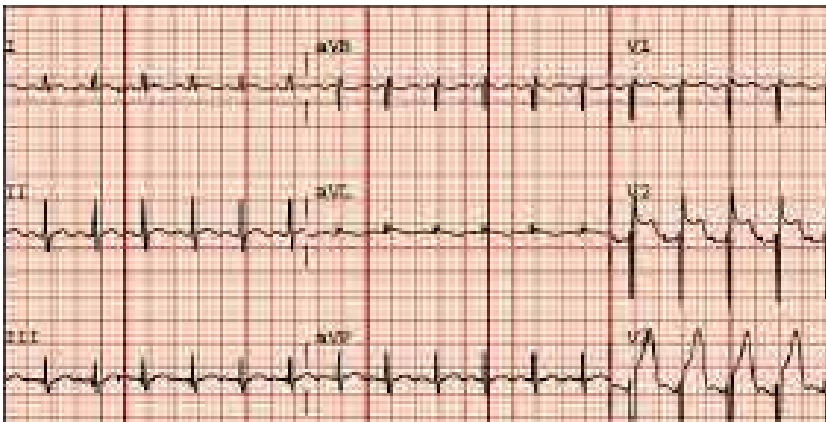
לכן חשוב לתשאל את המלווה - ההורה או המטפל העיקרי, ולהשוות למצב הבסיס כדי שלא להגיע לאבחון שגוי ובעקבותיו לתת טיפול שגוי.

בנוגע לטיפול ולפינוי חשוב לברר אם המטופל עבר ניתוח, אם יש שתל זר בגופו, וכן חשוב לבדוק מה צורת התקשורת המתאימה וכיצד הכי טוב לטפל בשתל כדי למנוע החמרה וכן כדי לבדוק שהמצב הרפואי אינו קשור אל השתל.

פגועי נפש, מתמודדי נפש

טיפול חירום בפגועי הנפש ומתמודדי נפש מעמיד בפני המטופלים אתגרים מכמה כיוונים. ראשית, שיתוף הפעולה יכול להיות מוגבל או כלל לא קיים. לעיתים המטפל עלול להיתקל בתגובה אלימה עד כדי סיכון הצוות המטפל, ולעיתים יש צורך להזעיק כוחות ביטחון.

שנית, אף אם שיתוף הפעולה משביע רצון, יש להביא בחשבון שבוחן המציאות של המטופל יכול להיפגע, ולכן ייתכן שהמטופל ימציא בעיות או ביטויים קליניים שאינם פעילים או למסך בעיות פעילות. המטופל יכול לנסות להסיט את השיחה לדיון בנושאים שאינם רלוונטיים. נוסף על כך, יש לזכור שמנעד תופעות הלוואי של התרופות הפסיכיאטריות הוא רחב ביותר ויכול להתבטא בהפרעות נפשיות, אריתמיות, בעיות מוטוריות, שינויים אלקטרוליטיים או בספירת הדם, בפריחות בעור והפרעות באוטונומיות (תרשים 18.4). תרופות אלו עשויות להתנגש עם התרופות שניתנות בטיפול השגרה ברמת השטח.



תרשים 18.4 הפרעת קצב כתופעת לוואי של תרופות פסיכיאטריות

בתמונה מופיעה דוגמה של אק"ג של מטופל צעיר הנוטל תרופה פסיכיאטרית מסוג Clozapine. באק"ג רואים LVH Anterior ST elevation, כינוס טכיקרדיה.